

Vanemaealise ühiskonna vajaduste rahuldamise eeldus on pädevad spetsialistid



Merle Varik

lektor, Tartu Tervishoiu
Kõrgkool; sotsiaaltöö
doktorant, Tallinna Ülikool



Reet Urban

õenduse dotsent,
Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Prognooside kohaselt kasvab vanemaealiste osakaal 2050. aastaks ligikaudu 30%ni elanikkonnast. Sellega kaasneb krooniliste südameveresoonkonna ja hingamiseliinikonna haiguste, kasvajate ning dementsuse esinemissageduse kasv, mille tagajärjel suureneb ühiskonnas see elanikkonna osa, kelle iseseisev toimetulek on piiratud (WHO 2015). Ravimisele keskendunud tervishoiumudel ei toeta inimese kui terviku elukvaliteeti, seda eriti vanemaealiste hulgas, kelle teised abivajadused võivad jääda märkamata olukorras, kus tegeldakse eeskätt ägedate terviseprobleemidega. Teisest küljest on tervishoiuteenuste osutajate seas levinud hoiak, et haigused on vanemas eas loomulik nähtus, mis loob soodsa pinnase olukorraks, kus inimese tervises seisundile ei pöörata piisavalt tähelepanu, aktiivravi vajadust alahinnatakse või siis ei osata ära tunda sekkumist vajavaid olukordi.

Kõikehõlmava ja efektiivse abi osutamiseks vanemaealisele elanikkonnale on esmatähtis abi asjakohasus ja järjepidevus. Professionaalne abi peaks olema tagatud efektiivselt toimiva interdistsiplinaarse meeskonnatöö tulemusena, kus kõik osapooled omavad eakatega töötamiseks vajalikke pädevusi.

Millised on vanemaealistega töötamiseks vajalikud pädevused

Vanemaealistega töötamine põhineb hoolivusel (ingl *caring*), mis Watsoni (1988) järgi tähendab humanistlik-altruistlikul väärtustesüsteemil rajanevat abi osutaja ja abi vastuvõtva isiku omavahelist professionaalset suhet. See on suhe, milles abi osutaja käsitleb abi vastuvõtjat kui unikaalset subjekti ega oma abivajaja suhtes eelarvamusi. Teisest küljest seisneb hoolivus niisuguse keskkonna loomises, mis ei pea silmas ainult füüsilist, vaid samavõrd ka vaimset ja hingelist keskkonda. Hoolivus väljendub inimese kaasamises tema abistamisprotsessi.

Rahvusvahelise projekti ELLAN¹ raames viidi läbi uurimistöö, mille käigus küsiti eakatele teenuseid osutavatel spetsialistidel (n=1282) nende arvamust eakatega töötamiseks vajalike pädevuste kohta. Valimi moodustasid kokku kuuest Euroopa riigist 226 arsti, 161 füsioterapeuti, 717 õde, 112 sotsiaaltöötajat ja 66 mõne muu eakatega töötava eriala esindajat. Kõige kõrgemalt hinnati pädevusi, mis väljenduvad koostöövõimes erinevate erialade spetsialistidest koosnevas meeskonnas; võimet hinnata vanemaealiste

¹ ELLAN – European Later Life Active Network 2013–2016. Projekti eesmärk on välja töötada Euroopa riikides vanemaealistega tegelevate spetsialistide pädevuste raam nõuded, mis oleksid ühtlasi aluseks õppekavade ja õppeprotsessi arendamisel kõrgkoolides. <http://ellan.savonia.fi/>

toimetulekut mõjutavaid tegureid (st hinnata nende funktsionaalset toimetulekut ning võimekust toetada ja suunata vanemaealist füüsilise ja psühhosotsiaalse iseseisvuse säilitamisel) ning oskust teadvustada ja aktsepteerida füsioloogilisi muutusi kui vananemisega kaasnevat normaalset protsessi, mitte kui haigestumist. Üheks võtmepädevuseks hinnati oskust juhtida interdistsiplinaarset meeskonnatööd. Oluliseks peeti ka võimekust teha koostööd eaka ja tema perekonnaga, oskust julgustada ja võimestada vanemaealist uskuma iseendasse, aidata tal märgata oma jõuvarusid, mitte keskenduda toimetulematusse.

Projekti raames intervjueriti ka 96 eakat kuuest riigist, et selgitada välja nende ootusi tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidele. Selgus, et vanemaealised väärtustavad kõrgelt isiksusekesksust, sealhulgas individuaalset lähenemist, hoolivust ja eetiliste väärtuste järgimist. Eakad soovivad, et spetsialistid oleksid oma ala kogenud eksperdid, kes oskavad luua professionaalsel suhtlusel põhinevat koostööd ning kaasavad vajaduste hindamisse ka perekonna. Professionaalselt abistajalt oodatakse „tervise advokaadi” rolli, kes võimestab aktiivselt vananemist ning hoolduses väärtustab emotsionaalset poolt. Abi osutajalt oodatakse ka võimet luua abi saajaga usaldusel põhinev suhe, mis tagaks abi saajale vabaduse väljendada oma tundeid ja emotsioone. Seega väljendub professionaalsus järjekindlas ja loovas probleemidele lahenduse leidmises.

Kuidas murda eakatega seonduvaid stereotüüpe

Kuigi uuringute põhjal on noorte hoiakud vanemaealiste suhtes hoolivad ja positiivsed, ei ole nendega tegelemine noorte tervishoiu- ja sotsiaaltöö spetsialistide seas populaarne (McKinlay ja Cowans 2003, Mason ja Sanders 2004, Gutheil jt 2009, Stevens 2011). Sama tulemuseni jõuti ka ELLANi projekti raames

tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna üliõpiaste hoiakuid uurides. Vastused koguti viiest riigist 955 üliõpilaselt öe (421), arsti (106), füsioterapeudi (120), sotsiaaltöö (96), tegevusterapeudi (73), toitumisenõustaja (14) ja hambaarsti (28) õppekavadelt. 75% osalejatest oli õppimise ajal positiivne hoiak ja valmisolek eakatega töötamiseks. Kõrgem oli valmisolek pärast kooli lõpetamist vanemaealise elanikkonnaga töötamiseks siiski üliõpilastel, kes olid vanemad kui 30 aastat ja/või kellel oli varasem töökogemus eakatega. Samas näitab tegelikkus, et kuigi õppides hinnati oma valmidust eakatega töötamiseks suureks, on kõrgkooli lõpetanutest eakatega tööle asunute osakaal siiski väike. Olenemata ettevalmistuse põhjalikkusest tundub õenduse üliõpilastele, et ainult eakatega töötamine ei paku neile piisavalt kliinilist kogemust, mis omakorda võib negatiivselt mõjutada nende tulevast karjääri. Äsja tööle asunud või kohe asuvate noorte ödede arvates ei ole eakatega töötamisel töökeskkond piisavalt köitev, mistõttu eelistatakse töötada kõrgtehnoloogilise tehnilise varustusega töökohal näiteks kirurgia või intensiivravi osakonnas (Stevens 2011, Kydd jt 2014).

Kuidas tagada geriaatria ja gerontoloogia valdkonnas järelkasv?

Iseenesestmõistetavalt tuleb eakatega tegelevate spetsialistide ettevalmistusega alustada juba kõrgkoolis. Kogemusõppe meetod (ingl *experiential learning*), kus eakad osalevad nendega töötavate spetsialistide õpetamises, on üks võimalus muuta õpe mõjusamaks. Mascidrelli (2014) uurimuses tõdesid sotsiaaltöö üliõpilased, et eakate kogemustest õppimine ja see, et nad väärtustasid üliõpilaste tööd ja pühendumust, aitas palju kaasa üliõpilaste gerontoloogiialase pädevuse kujunemisele. Oluline on

suunata noori teadlikult eakaid toetama ning murda stereotüüpsust suhtumist, justkui kõik eakad oleksid viletsa tervisega ega tuleks iseseisvalt toime. Gerontoloogia vastu huvi äratamiseks tuleks suunata üliõpilasi uurima vananemist kui protsessi, et nad mõistaksid, mis toimub nende endi, nende vanemate ja vanavanematega. Eakatega töötamiseks on

esmaltpuuduvad selgusele isiklikus hoiakus vananemisse ja vanemaelistesse. Õppejõude ja praktikajuhendajate positiivne suhtumine peegeldub ka üliõpilaste hoiakutes ja käitumises (Gutheil jt 2009, Kydd jt 2014). Seega Albert Schweitzeri mõttetera „Eeskuju ei ole peamine viis teisi mõjutada. See on ainus viis”, annab mõtteainet igapäevastele meist. **S**

Viidatud allikad

- Gutheil, I.A., Heyman, J.C., Chernesky, R.H.** (2009). Graduate Social Work Students' Interest in Working with Older Adults. *Social Work Education*. 28(1), 54–64.
- Kydd, A., Touhy, T., Newman, D., Fagerberg, I., Engstrom, G.** (2014). Attitudes towards caring for older people in Scotland, Sweden and the United States. *Nursing Older People*, 26(2), 33–40.
- Mason, S., Sanders, G.** (2004). Social Work Student Attitudes on Working with Older Clients. *Journal of Gerontological Social Work*. 423(3–4), 61–75.
- Mascidrelli, B.** (2014). „I Learned That the Aging Population Isn't That Much Different From Me”: The Final Outcomes of a Gero-Ed BEL Project. *Journal of Gerontological Social Work*. 57(1), 24–36.
- McKinlay, A., Cowans, S.** (2003). Student nurses' attitudes toward working with older patients. *Journal of Advanced Nursing*, 43(3), 298–309.
- Stevens, J. A.** (2011). Students nurses' career preferences for working with older people: a replicated longitudinal survey. *International Journal of Nursing Studies*. 48(8), 944–951.
- Watson, J.** (1988). Nursing: Human Science and Human Care: A Theory of Nursing. National League for Nursing, New York.
- World Health Organization.** (2015). World Report on Ageing and Health. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf?ua=1 (09.06.2016).